

1. Introducción y relevancia clínica

Toda hemorragia que ocurre **después de las 20 semanas de gestación** se considera **hemorragia del segundo o tercer trimestre**, y debe manejarse como **una urgencia obstétrica** hasta descartar las causas potencialmente letales:

- **Placenta previa.**
- **Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta (DPPNI).**

Ambas entidades tienen **fisiopatología, presentación y manejo distintos**, pero pueden confundirse clínicamente.

La correcta identificación permite **prevenir hemorragias masivas, sufrimiento fetal o muerte materno-fetal.**

2. Fisiopatología y bases conceptuales

A.

Placenta previa (PP)

Implantación anómala de la placenta en el **segmento uterino inferior**, cubriendo total o parcialmente el orificio cervical interno (OCI).

Clasificación (ecográfica)

1. **Oclusiva total:** cubre completamente el OCI.
2. **Oclusiva parcial:** cubre parcialmente el OCI.
3. **Marginal:** borde placentario llega al margen del OCI.
4. **Inserción baja:** borde placentario <2 cm del OCI, sin cubrirlo.

☐ **Solo puede diagnosticarse definitivamente después de las 28 semanas**, ya que antes puede migrar con el crecimiento uterino.

Fisiopatología:

Durante la formación del segmento inferior (T3), la placenta se separa parcialmente por estiramiento, generando **sangrado sin causa aparente ni dolor**.

B.

Desprendimiento Prematuro de Placenta Normoinserta (DPPNI)

Separación parcial o total de una placenta normalmente implantada, antes del nacimiento del feto y después de las 20 semanas.

Fisiopatología:

La ruptura de vasos deciduales provoca **hematoma retroplacentario**, que diseca la placenta del útero.

Esto genera:

- Hemorragia oculta (interna) o externa.
- Hipoxia fetal por pérdida de superficie de intercambio.
- Liberación de tromboplastina → coagulopatía por consumo (CID).

Factores de riesgo:

- Hipertensión o preeclampsia (más importante).
 - Trauma abdominal.
 - Tabaquismo y consumo de cocaína.
 - Rotura prematura de membranas.
 - Polihidroamnios o parto múltiple (decompresión brusca).
 - Antecedente de DPPNI previo.
-

3. Clínica: diferencias entre Placenta Previa y DPPNI

Característica	Placenta Previa	DPPNI
----------------	-----------------	-------

Dolor	Ausente	Intenso, continuo
Sangrado	Rojo brillante, indoloro	Oscuro, con coágulos
Tono uterino	Blando	Rígido, hipertónico
Altura uterina	Normal	Mayor que la esperada
Sufrimiento fetal	Frecuente si sangrado abundante	Muy frecuente
Shock materno	Proporcional al sangrado visible	Desproporcionado (sangrado oculto)
Tacto vaginal	Contraindicado	Puede realizarse bajo control en parto
Diagnóstico	Ecografía obstétrica	Clínico + eco + laboratorio

☐ **Nunca realizar tacto vaginal en hemorragia del tercer trimestre sin descartar placenta previa.**

4. Diagnóstico

A.

Placenta Previa

1. Clínica:

- Hemorragia **indolora, recurrente, rojo brillante**, en el **tercer trimestre**.
- Sin contracciones ni signos de irritación uterina.

- Signos vitales generalmente normales, pero puede haber anemia.

2. Exámenes:

- **Ecografía obstétrica:** método diagnóstico de elección.
 - Determina **ubicación placentaria y distancia al OCI**.
- **No realizar tacto vaginal** hasta confirmar por ecografía.
- **Hemograma y pruebas cruzadas.**

□ En Chile, se define placenta previa **solo si el borde placentario está a <2 cm del OCI después de las 28 semanas.**

B.

DPPNI

1. Clínica:

- Dolor abdominal intenso y persistente.
- Utero hipertónico, doloroso, con aumento de consistencia (“madera”).
- Sangrado oscuro, con o sin salida vaginal.
- Sufrimiento fetal agudo o muerte fetal.
- Hipotensión desproporcionada al sangrado visible.

2. Exámenes:

- **Ecografía:** puede mostrar hematoma retroplacentario (sensibilidad baja).
 - **Hemograma y coagulación:** anemia, consumo de fibrinógeno.
 - **Prueba de Kleihauer-Betke:** cuantifica hemorragia feto-materna.
 - **Evaluación fetal:** monitorización o ecografía Doppler.
-

5. Manejo

El manejo depende de la **estabilidad materna**, la **vitalidad fetal** y la **edad gestacional**.

A.

Placenta Previa

1. Conducta inicial:

- Hospitalizar.
- Reposo absoluto.
- Control de PA, signos vitales y sangrado.
- Vía venosa + fluidos.
- Reserva de sangre.
- Monitorización fetal continua.

2. Conducta según caso:

Condición	Conducta
Sangrado leve, feto vivo, EG <36 s	Manejo expectante en hospital. Corticoides para madurez pulmonar.
Sangrado recurrente o abundante	Cesárea programada según estabilidad.
Hemorragia masiva o compromiso materno/fetal	Cesárea urgente.

3. Vía de parto:

- **Cesárea electiva:** placenta oclusiva total o parcial.

- **Parto vaginal:** posible solo si placenta marginal o inserción baja y sangrado leve, con vigilancia intensiva.

☐ En placenta previa diagnosticada, el parto debe ser **hospitalario y con banco de sangre disponible**.

B.

DPPNI

1. Estabilización inicial:

- Hospitalización inmediata.
- Canalizar dos vías venosas gruesas.
- Cristaloides y transfusión según necesidad.
- Monitoreo materno-fetal continuo.
- Corrección de coagulopatía (fibrinógeno >150 mg/dL, plaquetas >50.000).
- Oxígeno y control de diuresis (>30 mL/h).

2. Conducta obstétrica:

Situación	Conducta
Feto vivo y parto inminente	Parto vaginal rápido si posible.
Feto vivo, parto no inminente	Cesárea urgente.
Feto muerto	Parto vaginal con oxitocina.
CID o shock	Corrección y resolución del parto.

☐ Si el feto ha fallecido, **el parto vaginal es preferible** para reducir riesgo materno.

6. Complicaciones

Placenta Previa	DPPNI
Hemorragia masiva	Shock hipovolémico
Anemia materna	CID (coagulación intravascular diseminada)
Placenta acreta/increta/percreta	Insuficiencia renal aguda
Cesárea repetida	Muerte fetal in útero
Prematurez	Hipoxia severa o encefalopatía neonatal
☐ Placenta acreta se asocia a cesárea previa + placenta previa → hemorragia postparto grave.	

7. Diferencias diagnósticas clave

Parámetro	Placenta Previa	DPPNI
Dolor	No	Sí
Sangrado	Rojo, indoloro	Oscuro, con coágulos
Tono uterino	Normal	Aumentado
Feto	Normal o sufrimiento tardío	Sufrimiento agudo o muerte

Diagnóstico Ecografía

Clínico + laboratorio

Tacto vaginal Contraindicado

Permitido con precaución

8. Seguimiento y prevención

- Control prenatal adecuado (≥ 6 controles).
 - Tratar factores de riesgo: HTA, tabaco, cocaína.
 - Ecografía de localización placentaria a las 32 s en pacientes con placenta baja.
 - Monitoreo fetal en todos los casos con sangrado.
 - Evitar trauma abdominal y exploraciones innecesarias.
-

9. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Placenta previa:** sangrado rojo, indoloro, sin hipertonía.
2. **DPPNI:** dolor intenso, útero hipertónico, sangrado oscuro.
3. **No hacer tacto vaginal** antes de descartar placenta previa por ecografía.
4. **Placenta previa total** → **cesárea obligatoria.**
5. **DPPNI con feto vivo** → **cesárea inmediata.**
6. **DPPNI con feto muerto** → **parto vaginal.**
7. **Complicación típica del DPPNI:** CID.
8. **Factores de riesgo de PP:** cesáreas previas, multiparidad, edad avanzada.



Errores comunes

- Realizar tacto vaginal antes de ecografía.
 - Demorar cesárea en DPPNI con sufrimiento fetal.
 - No corregir coagulopatía antes de cirugía.
 - No identificar riesgo de placenta acreta.
 - Manejo ambulatorio de sangrados moderados.
-

10. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Placenta previa:** sangrado rojo brillante, indoloro → diagnóstico ecográfico → **no tacto vaginal.**
2. **DPPNI:** dolor intenso, útero hipertónico, sangrado oscuro, sufrimiento fetal.
3. **Diagnóstico diferencial:** ecografía esencial para localizar la placenta.
4. **Placenta previa oclusiva total** → **cesárea electiva.**
5. **DPPNI con feto vivo** → **cesárea urgente; con feto muerto** → **parto vaginal.**
6. **CID** es complicación grave del DPPNI, requiere corrección activa.
7. Ambas son **emergencias obstétricas** que exigen manejo hospitalario con equipo y banco de sangre disponibles.